

Parasitosis intestinales: amebiasis, giardiasis, teniasis y enterobiasis

El examen correcto para cada parásito · Cuándo tratar y con qué · Amebicidas lumbinales y la trampa de *E. dispar*

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: PSD: parasitológico seriado de deposiciones · TAAN: test de amplificación de ácidos nucleicos · PCR: reacción en cadena de la polimerasa · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile · SNC: sistema nervioso central · TC/RM: tomografía computarizada / resonancia magnética · G6PD: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Alcance y fuentes. Basado en el DPDx de los CDC, las guías de la OMS sobre helmintiasis transmitidas por el suelo y sobre neurocisticercosis (IDSA/ASTMH 2018), y la literatura de referencia. **Los exámenes de referencia y las serologías se realizan en el ISP: verificar formularios y condiciones de envío. La hidatidosis, la triquinosis y otras parasitosis son de notificación obligatoria.**

Índice

1. Enfoque general
2. El examen correcto para cada parásito
3. Amebiasis
4. Giardiasis
5. Teniasis y cisticercosis
6. Enterobiasis (oxiuros)
7. Otras parasitosis intestinales relevantes
8. *Blastocystis* y *Dientamoeba*: ¿tratar o no?
9. Tratamiento: tabla resumen
10. Prevención y salud pública
11. Errores frecuentes
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. Enfoque general

Tres preguntas ordenan la consulta por sospecha de parasitosis intestinal:

1. **¿Qué síndrome tiene?** Diarrea aguda, diarrea crónica con malabsorción, disentería, prurito anal, dolor abdominal, eosinofilia, masa hepática, convulsiones. 2. **¿Cuál es la epidemiología?** Lugar de residencia y de origen, **viajes (incluso antiguos)**, agua no potable, alimentos crudos, contacto con animales, condiciones de saneamiento, institucionalización, práctica sexual oro-anal, inmunosupresión. 3. **¿Qué examen contesta mi pregunta?** — porque **el examen equivocado da un falso negativo garantizado** (el caso del oxiuro en el parasitológico es el ejemplo clásico).

Dos advertencias generales:

- La mayoría de las parasitosis intestinales en Chile son de baja prevalencia y curso benigno, pero su diagnóstico correcto evita tratamientos innecesarios y detecta las que sí importan.
- En el inmunosuprimido, el espectro y la gravedad cambian por completo: *Cryptosporidium*, *Cystoisospora*, microsporidios y la hiperinfección por *Strongyloides* son diagnósticos que hay que buscar activamente.

2. El examen correcto para cada parásito

Parásito	Examen de elección	Comentario
<i>Giardia lamblia</i>	Antígeno en deposiciones o PCR	Mucho más sensibles que la microscopía; el PSD requiere hasta 3 muestras
<i>Entamoeba histolytica</i>	Antígeno específico o PCR	La microscopía NO distingue <i>E. histolytica</i> de <i>E. dispar</i> (no patógena)
Absceso hepático amebiano	Serología (alta sensibilidad) más imagen	El PSD suele ser negativo
<i>Enterobius vermicularis</i> (oxiuro)	TEST DE GRAHAM (cinta adhesiva perianal)	Los huevos NO se encuentran en el PSD
<i>Taenia</i>	Proglótidas y huevos en deposiciones; antígeno	Los huevos no distinguen <i>T. saginata</i> de <i>T. solium</i>
Cisticercosis / neurocisticercosis	Neuroimagen más serología	El PSD es irrelevante para el diagnóstico
<i>Strongyloides stercoralis</i>	Serología (la más sensible); larvas en deposiciones con métodos de concentración (Baermann, agar)	Requiere muestras seriadas; buscar antes de inmunosuprimir
<i>Ascaris</i> , <i>Trichuris</i> , <i>uncinarias</i>	Huevos en PSD	Métodos de concentración aumentan el rendimiento
<i>Cryptosporidium</i> , <i>Cyclospora</i> , <i>Cystoisospora</i>	Kinyoun modificado, antígeno o PCR	Ácido-alcohol resistentes débiles; no se ven en el PSD estándar
Hidatidosis	Imagen (ecografía, TC) más serología	No puncionar con fines diagnósticos de rutina
<i>Fasciola hepatica</i>	Serología en la fase aguda; huevos en la fase crónica	Los huevos aparecen sólo meses después
Panel molecular gastrointestinal	PCR múltiple	Alta sensibilidad; exige criterio clínico para no tratar hallazgos irrelevantes

Reglas del parasitológico seriado: 3 muestras en días alternos (la eliminación es intermitente), con métodos de concentración; conservar adecuadamente y transportar según el protocolo del laboratorio.

3. Amebiasis

Entamoeba histolytica — protozoo con dos formas: **quiste** (infectante, resistente en el ambiente) y **trofozoíto** (invasor).

Transmisión: fecal-oral, por agua o alimentos contaminados; también por **práctica sexual oro-anal**.

El punto diagnóstico central: *E. histolytica* (patógena) es morfológicamente idéntica a *E. dispar* y *E. moshkovskii* (no patógenas). La microscopía informa "**complejo *E. histolytica/ E. dispar***", y **sólo el antígeno específico o la PCR permiten distinguirlas**. Como *E. dispar* es mucho más frecuente, **tratar todo hallazgo microscópico significa tratar mayoritariamente a personas sin enfermedad**.

Formas clínicas:

Forma	Clínica	Diagnóstico
Portación asintomática	Sin síntomas; la mayoría de los infectados	Antígeno o PCR
Colitis amebiana	Diarrea con sangre y mucus , dolor abdominal, pujo; instalación subaguda (días a semanas), habitualmente sin fiebre alta	Antígeno o PCR en deposiciones; colonoscopia con úlceras "en botón de camisa" y biopsia de los bordes
Colitis fulminante / megacolon tóxico	Grave, con perforación; más frecuente en desnutridos, embarazadas y con corticoides	Imagen; manejo quirúrgico
Ameboma	Masa inflamatoria colónica que simula neoplasia	Imagen, biopsia, serología
Absceso hepático amebiano	Fiebre y dolor en hipocondrio derecho , hepatomegalia dolorosa; habitualmente ÚNICO y en el lóbulo derecho; suele NO haber diarrea concomitante (< 30 %) . Leucocitosis SIN eosinofilia y fosfatasa alcalinas elevadas	Serología (sensibilidad > 90-95 % en el absceso) más imagen . El aspirado, si se realiza, muestra material "en pasta de anchoas" habitualmente estéril y sin trofozoítos
Extensión pleuropulmonar, pericárdica, cerebral	Complicaciones por extensión o diseminación	Imagen

Tratamiento — el punto que más se olvida:

La amebiasis invasora requiere SIEMPRE dos fármacos en secuencia: 1. **Un amebicida tisular: metronidazol 500-750 mg cada 8 h por 7-10 días** (o **tinidazol 2 g/día por 3-5 días**, mejor tolerado). 2. **SEGUIDO de un amebicida LUMINAL** para erradicar los quistes del lumen y prevenir la recaída y la transmisión: **paromomicina 25-35 mg/kg/día dividido en 3 dosis por 7 días**, o furoato de diloxanida, o yodoquinol.

Omitir el amebicida luminal es el error clásico, y explica una proporción importante de las recaídas.

- **Portación asintomática de *E. histolytica* confirmada:** se trata **sólo con amebicida luminal**, por el riesgo de progresión y de transmisión.
- **Portación de *E. dispar*:** **no se trata**.
- **Absceso hepático:** metronidazol seguido de amebicida luminal. **El drenaje NO es de rutina:** se reserva para abscesos muy grandes, del lóbulo izquierdo (riesgo de rotura al pericardio), con riesgo inminente de rotura, sin respuesta a los 5-7 días, o cuando no se puede descartar un absceso piógeno.

4. Giardiasis

Giardia lamblia (*G. duodenalis*, *G. intestinalis*)** — flagelado que coloniza el duodeno y yeyuno proximal, adhiriéndose a la mucosa sin invadirla.

Transmisión: fecal-oral; **agua contaminada** (es el parásito clásico del agua de arroyos y de sistemas mal tratados), alimentos, contacto persona a persona (jardines infantiles, instituciones), práctica sexual oro-anal.

Clínica:

- **Diarrea prolongada**, típicamente de **más de una semana**, con **deposiciones voluminosas, malolientes y esteatorreicas**, distensión, flatulencia, náuseas, **eructos sulfurosos**, dolor abdominal y **baja de peso**.
- **Ausencia de sangre, mucus y fiebre alta** (a diferencia de la colitis invasora).
- **No produce eosinofilia** (es un protozoo).
- **Malabsorción** con intolerancia secundaria a la lactosa, que puede persistir semanas tras la erradicación y explica la "falta de respuesta" aparente.
- Puede ser **asintomática** o autolimitada.
- **Sospechar inmunodeficiencia** (especialmente **déficit de IgA** o **inmunodeficiencia común variable**) ante giardiasis **recurrente o refractaria**.

Diagnóstico: **antígeno en deposiciones o PCR** (de elección, con sensibilidad muy superior); PSD seriado (3 muestras) con menor rendimiento; excepcionalmente aspirado duodenal o biopsia.

Tratamiento:

Fármaco	Esquema
Tinidazol	2 g VO en dosis única — alta eficacia y excelente adherencia
Metronidazol	250-500 mg cada 8 h por 5-7 días
Nitazoxanida	500 mg cada 12 h por 3 días
Alternativas en fracaso o embarazo	Paromomicina (no se absorbe: opción en el embarazo), albendazol, quinacrina; combinaciones en la giardiasis refractaria

- **Tratar a los contactos sintomáticos;** la portación asintomática se trata en contextos de brote o en manipuladores de alimentos según normativa.
- **Ante fracaso terapéutico:** verificar adherencia, considerar **reinfección, intolerancia transitoria a la lactosa** (que simula persistencia), **resistencia** (poco frecuente) e **inmunodeficiencia**.

5. Teniasis y cisticercosis

Es fundamental distinguir dos enfermedades muy distintas causadas por el mismo parásito.

	TENIASIS	CISTICERCOSIS
Qué es	Infección intestinal por la tenia adulta	Infección tisular por la larva (cisticerco)

	TENIASIS	CISTICERCOSIS
Cómo se adquiere	Comiendo carne cruda o mal cocida con larvas: <i>cerdo</i> (<i>T. solium</i>)** o <i>vacuno</i> (<i>T. saginata</i>)**	Ingiriendo HUEVOS de <i>T. solium</i> por vía fecal-oral, desde un portador humano de la tenia (que puede ser el propio paciente o un conviviente)
Localización	Intestino	Músculo, tejido subcutáneo, ojo y sobre todo SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Gravedad	Habitualmente banal	Puede ser grave: neurocisticercosis

La consecuencia práctica más importante La cisticercosis **NO se adquiere comiendo carne de cerdo, sino ingiriendo huevos eliminados por una persona portadora de *T. solium***. Por eso, **ante un caso de neurocisticercosis hay que estudiar y tratar a los convivientes** buscando el portador intestinal, y por eso la teniasis por *T. solium* es un problema de salud pública que va mucho más allá del portador.

Teniasis:

- **Clínica:** habitualmente **oligosintomática**; molestias abdominales vagas, y con frecuencia el motivo de consulta es **la observación de proglótidas** en las deposiciones o la ropa interior (*T. saginata* tiene proglótidas móviles que migran activamente).
- **Diagnóstico:** proglótidas y huevos en deposiciones. **Los huevos son idénticos entre las dos especies:** la diferenciación requiere el examen de las proglótidas (número de ramas uterinas), el escólex, o **PCR**. **Esta distinción importa**, porque *T. solium* implica riesgo de cisticercosis para el entorno.
- **Tratamiento:** praziquantel 5-10 mg/kg VO en dosis única, o niclosamida 2 g en dosis única. **Precaución:** si existe la posibilidad de **neurocisticercosis concomitante**, el praziquantel puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el SNC — **evaluar antes ante síntomas neurológicos**.

Neurocisticercosis:

- Es la principal causa de epilepsia adquirida en muchas regiones de América Latina.
- **Clínica:** convulsiones de inicio en el adulto (la manifestación más frecuente), cefalea, **hidrocefalia** (formas ventriculares y subaracnoideas), déficit focal, encefalitis.
- **Diagnóstico:** neuroimagen —quistes con **escólex visible** (patognomónico), lesiones en distintos estadios, calcificaciones— más **serología** (inmunoblot, más específico que el ELISA).
- **Tratamiento (guía IDSA/ASTMH 2018):** individualizado según el número, la localización y el estadio de las lesiones.
 - **Antiparasitarios:** albendazol, con **praziquantel asociado** en las formas con múltiples quistes viables.
 - **SIEMPRE con corticoides** para controlar la respuesta inflamatoria desencadenada por la muerte del parásito.
 - **Anticonvulsivantes** según la clínica.
 - **Manejo de la hidrocefalia** (derivación) en las formas ventriculares.
 - **Las lesiones calcificadas no se tratan con antiparasitarios.**
 - **Evaluación oftalmológica antes de tratar**, para descartar cisticercosis ocular (donde el tratamiento antiparasitario puede causar pérdida visual).
- **El manejo es especializado:** neurología, infectología y neurocirugía.

6. Enterobiasis (oxiuros)

Enterobius vermicularis — el helminto más prevalente en muchas regiones, incluidas las de altos ingresos.

- **Transmisión:** fecal-oral directa, por las manos y por fómites (ropa de cama, juguetes, superficies). Los huevos son infectantes en pocas horas y **resisten en el ambiente hasta 2-3 semanas**. La **autoinfección** por rascado perianal perpetúa el ciclo.
- **Predomina en niños en edad escolar**, con alta transmisión intrafamiliar.
- **Clínica:** **prurito anal de predominio NOCTURNO** (la hembra migra a la región perianal a poner los huevos durante la noche), irritabilidad, insomnio, exoriaciones perianales. Menos frecuente: **vulvovaginitis** en niñas, y casos anecdóticos de apendicitis y granulomas pelvianos.
- **NO produce eosinofilia** (permanece en el lumen intestinal).

Diagnóstico:

TEST DE GRAHAM (test de la cinta adhesiva): - Aplicar una cinta adhesiva transparente en la **región perianal, al despertar, ANTES del aseo y antes de defecar.** - Repetir en **3 días consecutivos** aumenta el rendimiento por sobre el 90 %. - **Los huevos NO se detectan en el parasitológico de deposiciones:** pedirlo para buscar oxiuros es garantizar un falso negativo.

Tratamiento:

- **Mebendazol 100 mg VO en dosis única, albendazol 400 mg en dosis única**, o pamoato de pirantel 11 mg/kg (máximo 1 g).
- **REPETIR LA DOSIS A LAS 2 SEMANAS** — es imprescindible, porque los fármacos no actúan sobre los huevos y la reinfección desde el ambiente es la regla.
- **TRATAR SIMULTÁNEAMENTE A TODOS LOS CONVIVIENTES**, sintomáticos o no.
- **Medidas ambientales**, tan importantes como el fármaco: lavado de manos frecuente y **cepillado de uñas**, mantener las uñas cortas, **lavar la ropa de cama, toallas y ropa interior con agua caliente** (sin sacudirlas, para no dispersar los huevos), aseo matinal de la región perianal, y limpieza de superficies. Las medidas se mantienen durante al menos 2 semanas.
- **Evitar el albendazol y el mebendazol en el primer trimestre del embarazo;** el pamoato de pirantel es una alternativa.

7. Otras parasitosis intestinales relevantes

Parásito	Clínica	Tratamiento
<i>Ascaris lumbricoides</i>	Habitualmente asintomático; obstrucción intestinal o biliar con carga alta; síndrome de Löffler (infiltrados pulmonares migratorios con eosinofilia) durante la migración larvaria	Albendazol 400 mg dosis única o mebendazol
<i>Trichuris trichiura</i>	Diarrea crónica, prolapso rectal en infestación masiva, anemia	Albendazol 400 mg/día por 3 días o mebendazol
Uncinarias (<i>Ancylostoma</i> , <i>Necator</i>)	Anemia ferropriva por pérdida crónica de sangre; larva migrans cutánea en la penetración	Albendazol 400 mg dosis única; corregir el hierro
<i>Strongyloides stercoralis</i>	Diarrea, dolor abdominal, larva currens (lesión serpiginosa migratoria muy pruriginosa), eosinofilia. Autoinfección durante décadas; hiperinfección con corticoides	Ivermectina 200 µg/kg/día por 2 días (prolongada en la hiperinfección). BUSCAR ANTES DE INMUNOSUPRIMIR
<i>Diphyllobothrium</i>	Consumo de pescado crudo o mal cocido , relevante con salmónidos ; habitualmente asintomático; déficit de vitamina B12 con anemia megaloblástica	Praziquantel dosis única
<i>Hymenolepis nana</i>	Tenia enana; niños e instituciones; autoinfección	Praziquantel 25 mg/kg dosis única
<i>Cryptosporidium</i>	Diarrea acuosa; autolimitada en el inmunocompetente, crónica y grave en VIH avanzado	Nitazoxanida; en VIH, lo esencial es la terapia antirretroviral
<i>Cyclospora</i> , <i>Cystoisospora</i>	Diarrea prolongada; brotes por alimentos importados	Cotrimoxazol
Microsporidios	Diarrea crónica en inmunosuprimidos	Albendazol (<i>Encephalitozoon</i>), fumagilina
<i>Trichinella spiralis</i>	Carne de cerdo o jabalí mal cocida; fiebre, mialgias intensas, edema periorbitario, eosinofilia marcada , alza de CK	Albendazol más corticoides; notificación obligatoria

8. Blastocystis y Dientamoeba: ¿tratar o no?

Es una duda clínica frecuente y vale la pena resolverla explícitamente:

- **Blastocystis hominis:** hallazgo muy frecuente en el PSD, y su patogenicidad es **discutida**. Se encuentra con igual frecuencia en personas asintomáticas. **La conducta razonable es NO tratarlo de rutina**, y considerar el tratamiento sólo en pacientes sintomáticos en quienes **se han descartado todas las demás causas**, incluidas las no infecciosas. Si se trata: metronidazol o cotrimoxazol.
- **Dientamoeba fragilis:** patogenicidad también debatida, con más evidencia de asociación a síntomas que *Blastocystis*. Tratamiento: paromomicina, metronidazol o doxiciclina, en casos sintomáticos seleccionados.
- **Amebas no patógenas** (*Entamoeba coli*, *Endolimax nana*, *Iodamoeba*, *Chilomastix*): **NO se tratan**. Su hallazgo sólo indica exposición fecal-oral, y es un marcador de condiciones sanitarias, no de enfermedad.

El principio general: un hallazgo parasitológico sin cuadro clínico compatible, y sin que el parásito sea patógeno reconocido, no se trata. Tratar "por si acaso" genera efectos adversos y no resuelve los síntomas, que suelen tener otra causa (frecuentemente funcional).

9. Tratamiento: tabla resumen

Parásito	Tratamiento de elección
<i>Giardia</i>	Tinidazol 2 g dosis única o metronidazol 5-7 días
<i>E. histolytica</i> invasora	Metronidazol o tinidazol + amebicida luminal (paromomicina)
<i>E. histolytica</i> asintomática	Sólo amebicida luminal
<i>E. dispar</i>	No tratar
Absceso hepático amebiano	Metronidazol + amebicida luminal; drenaje sólo en casos seleccionados
<i>Enterobius</i> (oxiuro)	Mebendazol o albendazol dosis única, REPETIR A LAS 2 SEMANAS, tratar a todos los convivientes
<i>Taenia</i> (teniasis)	Praziquantel dosis única (o niclosamida)
Neurocisticercosis	Albendazol ± praziquantel + CORTICOIDES, individualizado, manejo especializado
<i>Ascaris</i> , <i>Trichuris</i> , <i>uncinarias</i>	Albendazol (dosis única o 3 días según especie)
<i>Strongyloides</i>	Ivermectina
<i>Diphyllobothrium</i> , <i>Hymenolepis</i>	Praziquantel
<i>Cryptosporidium</i>	Nitazoxanida; terapia antirretroviral en VIH
<i>Cyclospora</i> , <i>Cystoisospora</i>	Cotrimoxazol
<i>Blastocystis</i> , amebas no patógenas	En general, no tratar

En el embarazo: evitar albendazol y mebendazol en el **primer trimestre**; el metronidazol se considera seguro; la **paromomicina** (no absorbible) es una buena opción para amebiasis y giardiasis; la **ivermectina** se evita salvo necesidad; el praziquantel es aceptable.

10. Prevención y salud pública

- **Agua potable segura y saneamiento** — la intervención estructural de mayor impacto.
- **Higiene de manos**, especialmente antes de comer y después de ir al baño y de cambiar pañales.
- **Lavado de verduras y frutas**; evitar el consumo de agua no tratada.
- **Cocción adecuada de carnes** (cerdo, vacuno, jabalí) y de **pescado**; la congelación adecuada también inactiva larvas.
- **Control de la crianza porcina y de la faena informal** — clave en la prevención de la teniasis por *T. solium*, la cisticercosis y la triquinosis.
- **Tratamiento del caso índice y de los convivientes** en enterobiasis y en teniasis por *T. solium*.
- **Notificación obligatoria** de hidatidosis, triquinosis y otras parasitosis según el decreto vigente; **confirmación en el ISP**.
- **Evitar la práctica sexual oro-anal sin protección** o extremar la higiene, por el riesgo de transmisión de amebiasis y giardiasis.

11. Errores frecuentes

- Pedir parasitológico de deposiciones para buscar oxiuros: se busca con **test de Graham**. - Hacer el test de Graham después del aseo matinal o de defecar. - Tratar el oxiuro con una sola dosis y sin tratar a los convivientes. - Tratar todo hallazgo de "*E. histolytica*/*E. dispar*" en la microscopía**, sin confirmar la especie con antígeno o PCR. - Omitir el amebicida luminal tras el metronidazol en la amebiasis invasora. - Drenar de rutina un absceso hepático amebiano. - Confundir teniasis con cisticercosis, y no estudiar a los convivientes de un caso de neurocisticercosis. - Dar praziquantel a un portador de tenia con síntomas neurológicos sin descartar antes neurocisticercosis. - Tratar la neurocisticercosis sin corticoides ni evaluación oftalmológica previa. - Pedir una sola muestra para parasitológico. - Tratar *Blastocystis* y amebas no patógenas de rutina. - No buscar *Strongyloides* antes de indicar corticoides. - Tratar hallazgos de un panel molecular sin correlato clínico.

12. Perlas de alto rendimiento

- El examen equivocado garantiza un falso negativo: oxiuro = test de Graham, no parasitológico.
- Repetir la dosis del antihelmíntico a las 2 semanas y tratar a todos los convivientes en la enterobiasis.
- La microscopía no distingue *E. histolytica* de *E. dispar*: se requiere antígeno o PCR.
- La amebiasis invasora exige metronidazol MÁS un amebicida luminal: omitirlo causa recaídas.
- Absceso hepático amebiano: único, lóbulo derecho, sin diarrea, sin eosinofilia, serología muy sensible, y en general NO se drena.
- Giardiasis: diarrea prolongada con esteatorrea y sin sangre ni eosinofilia; tinidazol 2 g en dosis única.
- La giardiasis recurrente obliga a descartar déficit de IgA o inmunodeficiencia común variable.
- La "falta de respuesta" en giardiasis suele ser intolerancia transitoria a la lactosa.
- TENIASIS != CISTICERCOSIS: la cisticercosis se adquiere ingiriendo huevos de un portador humano, no comiendo carne.
- Ante neurocisticercosis, estudiar a los convivientes buscando el portador intestinal.
- Neurocisticercosis: antiparasitario SIEMPRE con corticoides, y evaluación oftalmológica previa; las lesiones calcificadas no se tratan.
- *Diphyllobothrium* -> déficit de vitamina B12; uncinarias -> anemia ferropriva.
- *Blastocystis* y las amebas no patógenas, en general, no se tratan.
- *Strongyloides* se busca ANTES de inmunosuprimir, y su eosinofilia desaparece en la hiperinfección.

13. Bibliografía esencial

- Centers for Disease Control and Prevention. *DPDx — Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern*. Disponible en www.cdc.gov/dpdx.
- Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 IDSA clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea. *Clin Infect Dis*. 2017;65:e45-e80.
- White AC, Coyle CM, Rajshekhar V, et al. Diagnosis and treatment of neurocysticercosis: 2017 clinical practice guidelines by the IDSA and the American Society of Tropical Medicine and Hygiene. *Clin Infect Dis*. 2018;66:e49-e75.
- Haque R, Huston CD, Hughes M, et al. Amebiasis. *N Engl J Med*. 2003;348:1565-73.
- Stanley SL. Amoebiasis. *Lancet*. 2003;361:1025-34.
- Requena-Méndez A, Buonfrate D, Gomez-Junyent J, et al. Evidence-based guidelines for screening and management of strongyloidiasis in non-endemic countries. *Am J Trop Med Hyg*. 2017;97:645-52.
- World Health Organization. *Guideline: preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections*. Edición vigente.
- Instituto de Salud Pública de Chile. Manuales de toma de muestra y formularios de derivación en parasitología. Disponible en www.ispch.cl.